

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Tendencias epidemiológicas integradas de Costa Rica

2025-2026 · Población adulta mayor y panorama nacional

Fuente	Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica
Cobertura	72 boletines semanales únicos y 5 mensuales de 2025-2026
Elaboración	25 de julio de 2026

Documento de análisis secundario. Los datos recientes son preliminares y están sujetos a revisión.

2025-2026: población adulta mayor y panorama nacional

Fuente: Boletines epidemiológicos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Fecha de elaboración: 25 de julio de 2026.

Enfoque principal: personas de 65 años y más.

Resumen ejecutivo

Indicadores clave del último corte disponible

Evento	Casos	Corte	Señal principal
IRAG	7.627 → 4.600	SE 24	-39,7%
Dengue	1.677 → 1.805	SE 26	+8,0%
EDA	197.139 → 237.833	SE 24	+20,6%
Sífilis 65+	129 → 151	SE 24	+17,1%
Miasis 65+	25 → 24	SE 27	-4,0%
Miasis % 65+	46,3 → 52,2	SE 27	+5,9 puntos
Meningitis	109 → 116	SE 26	+6,4%

El análisis integrado de los boletines epidemiológicos de 2025 y 2026 muestra que las personas adultas mayores enfrentan un perfil de riesgo distinto al de la población general. En ellas se concentran desproporcionadamente las infecciones respiratorias agudas graves y la miasis por gusano barrenador; persiste además una carga importante de sífilis y aparecen riesgos no infecciosos relacionados con violencia, negligencia, caídas y salud mental.

La comparación debe considerar que los periodos no son equivalentes: los archivos de 2025 alcanzan principalmente las SE 47-50 y algunos datos a la SE 52, mientras 2026 llega a las SE 24-27. Cuando fue posible se compararon cortes iguales; en los demás casos se presentan trayectorias, no diferencias porcentuales directas.

Los principales resultados para la población de 65 años y más son:

- IRAG persistentemente concentrada en mayores de 75 años.** Este grupo aparece entre los de mayor número de casos tanto en 2025 como en 2026. A la SE 24, las IRAG totales disminuyeron de 7.627 en 2025 a 4.600 en 2026, una reducción de 39,7%. No puede afirmarse que la misma reducción ocurrió específicamente en mayores porque los boletines no publican el total numérico agregado de 65 años y más.
- Miasis con menor número en 2026, pero mayor concentración proporcional en personas mayores.** Al corte comparable de la SE 27, los casos totales disminuyeron de 54 en 2025 a 46 en 2026, 14,8% menos. Los casos de 65 años y más pasaron de 25 a 24, una reducción de solo un caso. Como resultado, su participación aumentó de 46,3% a 52,2%.
- Sífilis en aumento en personas mayores.** A la SE 24 se registraron 129 casos en 65 años y más durante 2025 y aproximadamente 151 en 2026, aumento de 17,1%. El total nacional aumentó 30,3%, por lo que la participación proporcional de las personas mayores disminuyó levemente, aunque su número absoluto creció.
- EDA con menor incidencia relativa en mayores, pero mayor riesgo potencial de complicaciones.** En 2026 la tasa notificada en 65 años y más fue 2.102 por 100.000, inferior a la de niños pequeños y

adultos jóvenes. Los boletines no permiten comparar hospitalización, deshidratación o mortalidad por edad.

5. **Violencia y negligencia como problema sanitario de primer orden.** A la SE 43 de 2025 se notificaron 20.439 casos de violencia intrafamiliar y el grupo de 75 años y más alcanzó una tasa de 478,2 por 100.000. En el análisis detallado de la SE 35, 2.238 casos fueron clasificados como adultos mayores; 59% correspondió a mujeres y predominó la negligencia o abandono. No existe un informe equivalente para 2026.
6. **Caídas y accidentes domésticos como principal componente de mortalidad externa.** El informe publicado en 2026, con datos de cierre completo de 2025, registró 699 muertes por otras causas externas en personas de 65 años y más, equivalentes a 60,9% de las 1.148 registradas en todo el país. En cambio, solo 17 de los 803 homicidios nacionales (2,1%) ocurrieron en este grupo, lo que invierte el patrón de riesgo externo observado en adultos de 15-64 años.

Para el país en general, el primer semestre de 2026 muestra menos IRAG, IRAS y ETI que el mismo corte de 2025, pero más dengue, EDA, meningitis y las tres ITS analizadas. La malaria presenta más transmisión local en 2026 que en el corte equivalente de 2025, aunque permanece muy por debajo de 2023-2024. La miasis muestra una reducción interanual moderada.

1. Alcance y comparabilidad

1.1 Cobertura

El análisis integra:

- 47 boletines semanales únicos y un mensual de 2025, con últimos cortes principalmente entre las SE 42 y 50.
- 25 boletines semanales y cuatro mensuales de 2026, con últimos cortes entre las SE 24 y 27.
- Los diagnósticos y matrices de evidencia elaborados para cada año.

La carpeta 2025 llega al Boletín N.º 49, publicado el 26 de diciembre, con cobertura cercana al cierre anual. No contiene los números 50-52 y las cifras continúan siendo preliminares.

1.2 Reglas de comparación

Se utilizan tres categorías:

- **Comparación directa:** mismo indicador y misma semana epidemiológica en ambos años.
- **Tendencia parcial:** indicadores con cortes diferentes que permiten describir dirección, pero no calcular cambio válido.
- **Hallazgo exclusivo:** información publicada solo en uno de los años.

No se comparan acumulados con diferente número de semanas como si fueran tasas anuales. Tampoco se atribuyen cambios a una causa específica sin microdatos.

2. Población adulta mayor

2.1 Perfil integrado de vulnerabilidad

Los boletines permiten identificar cuatro dimensiones de riesgo:

- **Infecciosa grave:** IRAG y miasis.
- **Infecciosa persistente:** sífilis, meningitis y otras ITS.

- **Lesiones y dependencia:** heridas, caídas y accidentes domésticos.
- **Psicosocial:** violencia intrafamiliar, negligencia, abandono e intentos de suicidio.

El grupo de 75 años y más presenta la mayor acumulación de señales: máximo de IRAG, máxima carga quinquenal de miasis, aumento de violencia con la edad y predominio masculino en intentos de suicidio.

2.2 Infecciones respiratorias graves

En ambos años las IRAG muestran un patrón bimodal: la mayor carga se concentra en niños pequeños y mayores de 75 años.

A la SE 24:

- 2025: 7.627 IRAG.
- 2026: 4.600.
- Diferencia: 3.027 casos menos; reducción de 39,7%.

También disminuyeron IRAS y ETI en el corte comparable:

- IRAS: de 750.863 a 649.865; reducción de 13,5%.
- ETI: de 10.609 a 7.212; reducción de 32,0%.

Estas disminuciones describen el total nacional. La ausencia de tablas numéricas completas por edad impide calcular el cambio específico en personas mayores.

En 2025 se documentó presión hospitalaria pediátrica de 153,73% al 22 de diciembre. En 2026, los datos disponibles hasta junio mostraron predominio de rinovirus y parainfluenza, con SARS-CoV-2 en tercer lugar de circulación. En ambos años, COVID-19 fue solo una parte de la carga respiratoria.

Interpretación: el descenso general en 2026 es favorable, pero las personas mayores de 75 continúan siendo un grupo prioritario por gravedad potencial, multimorbilidad y riesgo de hospitalización.

2.3 Miasis por gusano barrenador

La miasis es el evento con evidencia más sólida de concentración en personas mayores.

Al corte de la SE 27:

- 2025: 54 casos totales; 25 en personas de 65 años y más.
- 2026: 46 casos totales; 24 en personas de 65 años y más.
- Cambio total: -14,8%.
- Cambio en 65 años y más: -4,0%.
- Participación de 65 años y más: de 46,3% a 52,2%.

Aunque el número disminuyó, la reducción fue mucho menor en la población mayor que en el total. Esto indica persistencia de vulnerabilidad relativa.

En el corte más avanzado de 2025, SE 50, se registraron 96 casos, de los cuales 48 correspondieron a mayores de 65: exactamente la mitad. En 2026, a la SE 27, 16 de los 46 casos se concentraban en mayores de 75, el grupo quinquenal más afectado.

La distribución territorial cambió parcialmente:

- 2025: mayor número en Alajuela; mayores tasas en Limón y Guanacaste; regiones Huetar Caribe y Central Norte con mayor volumen.
- 2026: Puntarenas y Alajuela concentraron diez casos cada una; Huetar Norte y Central Sur fueron las regiones con mayor número.

Interpretación: la miasis debe tratarse como un síndrome centinela de vulnerabilidad, cuidado de heridas y dependencia. La circulación animal obliga a mantener el enfoque de Una Sola Salud.

2.4 Sífilis y otras ITS

Sífilis

A la SE 24:

- Casos totales: 1.302 en 2025 y 1.696 en 2026; aumento de 30,3%.
- Casos en 65 años y más: 129 en 2025 y aproximadamente 151 en 2026; aumento de 17,1%.
- Participación de mayores: cerca de 9,9% en 2025 y 8,9% en 2026.

El crecimiento absoluto confirma transmisión persistente en edades avanzadas, aunque el aumento fue más rápido en grupos jóvenes.

En el corte de la SE 49 de 2025, las personas mayores sumaban 297 casos, 9,4% del total. La carga no desaparece con la edad y sigue siendo epidemiológicamente relevante.

Gonorrea y herpes

En 2025, a la SE 24, se registraron 15 casos de gonorrea y 17 de herpes en personas de 65 años y más. En el corte de la SE 49 fueron 36 y 51, respectivamente.

Los boletines de 2026 muestran persistencia en edades avanzadas, pero no publican en texto un total agregado comparable. En el conjunto nacional, gonorrea aumentó 10,8% y herpes 6,4% a la SE 24.

Interpretación: la atención sexual y reproductiva debe incluir a las personas mayores. La edad no elimina exposición, necesidad de diagnóstico ni tratamiento de parejas.

2.5 Enfermedad diarreica aguda

En 2026 la tasa de EDA en personas de 65 años y más fue de 2.102 por 100.000, menor que las tasas de niños y adultos jóvenes. Sin embargo, el boletín no publica hospitalización, deshidratación o mortalidad por edad.

En el total nacional, a la SE 24:

- 2025: 197.139 casos.
- 2026: 237.833.
- Aumento: 20,6%.

El aumento nacional no puede trasladarse automáticamente a la población mayor. No obstante, una mayor circulación comunitaria incrementa su exposición y puede generar mayor gravedad por reserva fisiológica reducida, comorbilidad y uso de medicamentos.

2.6 Meningitis

A la SE 26, los casos sospechosos aumentaron de 109 en 2025 a 116 en 2026, 6,4%. Los gráficos de ambos años muestran casos en 65-69, 70-74 y mayores de 75, pero no hay un total agregado comparable.

Los menores de un año fueron el principal grupo afectado. En mayores, la vigilancia debe centrarse en reconocimiento temprano, gravedad y etiología, no en asumir que son el grupo de mayor incidencia.

2.7 Violencia intrafamiliar

El informe tardío de 2025 notificó 20.439 casos de violencia intrafamiliar hasta la SE 43 y señaló una tasa de 478,2 por 100.000 en el grupo de 75 años y más. El análisis detallado de la SE 35 clasificó 2.238 casos como adultos mayores:

- Mujeres: 1.320; 59%.
- Hombres: 918; 41%.
- Negligencia o abandono: 778; 34,8%.
- Abuso psicológico: 648; 29,0%.
- Abuso físico: 356; 15,9%.
- Otros síndromes mixtos: 281.
- Maltrato no especificado: 129.
- Abuso sexual: 23.
- Violencia patrimonial: 23.

La incidencia aumentó con la edad y alcanzó el punto más alto en mayores de 75. Las mujeres tuvieron mayores tasas entre 60-74; en mayores de 75 los hombres las superaron ligeramente.

No existe un informe equivalente en los archivos de 2026. Además, el boletín advierte que algunas cifras pueden incluir personas de 60-64, aunque la definición legal es 65 años y más.

2.8 Intentos de suicidio y salud mental

En 2025, a la SE 42, la tasa agregada publicada para personas de 65 años y más fue 7,6 por 100.000. El boletín destaca que, aunque menor que en adolescentes, los intentos en edades avanzadas pueden tener alta letalidad.

No hay un análisis equivalente en los boletines 2026. El riesgo debe interpretarse junto con aislamiento, duelo, dolor crónico, deterioro funcional, dependencia y violencia.

2.9 Mortalidad externa y caídas

El boletín de 2026 publicó datos preliminares de mortalidad correspondientes a 2025:

- 699 muertes en personas de 65 años y más por “otras causas externas”.
- 17 homicidios en el mismo grupo.

La categoría de otras causas externas incluye caídas, ahogamientos y accidentes caseros. Este resultado sitúa la prevención de caídas y seguridad del hogar entre las principales prioridades no transmisibles.

2.10 Conclusión para la población adulta mayor

Entre 2025 y 2026 se observa:

- Persistencia de IRAG en mayores de 75, a pesar del descenso respiratorio general.
- Menos miasis total, pero una proporción mayor de casos concentrada en 65 años y más.
- Aumento absoluto de sífilis en mayores.
- Falta de continuidad estadística para violencia, intentos de suicidio, caídas y gravedad de EDA.

La señal más importante no es una única enfermedad, sino la acumulación de riesgos en personas con dependencia, heridas crónicas, multimorbilidad o aislamiento.

3. Tendencias generales del país

3.1 Comparación al mismo periodo

Eventos con aumento en 2026

- Dengue a la SE 26: de 1.677 a 1.805; +8%.
- EDA a la SE 24: de 197.139 a 237.833; +20,6%.
- Meningitis a la SE 26: de 109 a 116; +6,4%.
- Sífilis a la SE 24: de 1.302 a 1.696; +30,3%.
- Gonorrea a la SE 24: de 637 a 706; +10,8%.
- Herpes a la SE 24: de 405 a 431; +6,4%.

Eventos con disminución en 2026

- IRAG a la SE 24: de 7.627 a 4.600; -39,7%.
- IRAS a la SE 24: de 750.863 a 649.865; -13,5%.
- ETI a la SE 24: de 10.609 a 7.212; -32,0%.
- Miasis a la SE 27: de 54 a 46; -14,8%.

Malaria

La transmisión local aumentó en el corte comparable:

- 2025 a la SE 26: aproximadamente 9 casos de transmisión local.
- 2026 a la SE 26: 20.

Esto supone más del doble, aunque la cifra de 2026 permanece muy por debajo de los niveles observados en 2023 y 2024. El foco principal cambió de Matina en 2025 hacia Crucitas y Los Chiles en 2026, sin desaparecer el riesgo en el Caribe.

3.1bis Razón de tasas ajustada por población

Las comparaciones anteriores expresan variación porcentual de casos absolutos. Para aproximar una razón de tasas (rate ratio, RR) se requiere un denominador poblacional para cada año. El propio Ministerio de Salud publica, en cada boletín, una tasa nacional junto al número de casos para dengue en ambos años (5.622 casos y tasa 108,3 por 100.000 a la SE 49 de 2025; 1.805 casos y tasa 34,6 por 100.000 a la SE 26 de 2026). De ahí se derivan poblaciones implícitas de aproximadamente **5.191.000 habitantes (corte 2025)** y **5.217.000 habitantes (corte 2026)**, consistentes con el crecimiento demográfico esperado de Costa Rica (~0,5% en el periodo). Estas poblaciones implícitas —y no una cifra externa— se usan como denominador para calcular un RR ajustado por población para el resto de eventos, aplicando el factor de corrección $P_{2025}/P_{2026} = 0,9951$ al cociente de casos.

El ajuste es pequeño (bajo un punto porcentual en todos los casos) porque el crecimiento poblacional interanual es marginal frente a los cambios epidemiológicos observados; aun así, es la forma correcta de reportar una razón de tasas cuando no se dispone de la tasa oficial en ambos cortes.

Evento	Corte	Casos 2025	Casos 2026	Variación cruda	RR ajustado por población	Variación ajustada
IRAG	SE 24	7.627	4.600	-39,7%	0,600	-40,0%
IRAS	SE 24	750.863	649.865	-13,5%	0,861	-13,9%
ETI	SE 24	10.609	7.212	-32,0%	0,676	-32,4%
Dengue	SE 26	1.677	1.805	+7,6%	1,071	+7,1%
EDA	SE 24	197.139	237.833	+20,6%	1,200	+20,0%

Evento	Corte	Casos 2025	Casos 2026	Variación cruda	RR ajustado por población	Variación ajustada
Meningitis	SE 26	109	116	+6,4%	1,059	+5,9%
Sífilis (total)	SE 24	1.302	1.696	+30,3%	1,296	+29,6%
Sífilis (65 y más)	SE 24	129	151	+17,1%	1,165	+16,5%
Gonorrrea	SE 24	637	706	+10,8%	1,103	+10,3%
Herpes simple	SE 24	405	431	+6,4%	1,059	+5,9%
Miasis (total)	SE 27	54	46	-14,8%	0,848	-15,2%
Miasis (65 y más)	SE 27	25	24	-4,0%	0,955	-4,5%
Malaria, transmisión local	SE 26	9	20	+122,2%	2,211	+121,1%

Lectura: en todos los casos la corrección poblacional desplaza la variación entre 0,4 y 1,1 puntos porcentuales respecto de la variación cruda, sin cambiar el sentido ni la magnitud sustantiva de ninguna tendencia. Esto confirma que las conclusiones de este informe son robustas frente al supuesto simplificador de población constante usado en versiones previas, y a la vez documenta el procedimiento correcto para reportarlas con rigor técnico.

3.2 Dengue

El comportamiento cambió entre ambos años:

- 2025 tuvo una reducción de 82% respecto de 2024 a la SE 38, comenzó a ascender desde la SE 27 y cerró el corte disponible con 5.622 casos a la SE 49.
- 2026 inició con menor carga acumulada que 2025, pero desde la SE 17 aumentó rápidamente y a la SE 26 ya superaba en 8% el mismo corte del año anterior.

Territorialmente, 2025 estuvo dominado por Central Sur y el cantón de San José, mientras 2026 mostró mayor volumen en Central Norte y alta intensidad en Pacífico Central, especialmente Orotina.

Interpretación: el riesgo se desplazó territorialmente y se adelantó en 2026. El control debe anticipar incrementos antes del pico lluvioso.

3.3 Enfermedad respiratoria

Los tres grandes indicadores respiratorios fueron menores en 2026 al corte comparable. Esto sugiere una temporada menos intensa durante el primer semestre, pero no elimina:

- La concentración de IRAG en los extremos de la vida.
- El riesgo de cambios rápidos en circulación viral.
- La necesidad de preparación hospitalaria.

En 2025 se observó presión pediátrica importante más adelante en el año. Los archivos 2026 aún no alcanzan ese periodo, por lo que no puede concluirse cómo terminará la temporada.

3.4 EDA

La EDA fue 20,6% mayor en 2026 a la SE 24. Ambos años presentaron señales de alerta:

- 2025 tuvo picos y entrada a zona de alerta, seguida de descenso desde la SE 26.

- 2026 mostró incrementos entre las SE 12-22 y entrada transitoria en alerta, con rezago de notificación estimado en al menos 10%.

Interpretación: la EDA permanece como evento de gran magnitud y sensibilidad climática y sanitaria. El aumento de 2026 exige vigilancia de agua, alimentos y brotes territoriales.

3.5 ITS

Las tres ITS aumentaron en ambos periodos:

- 2025 frente a 2024: sífilis +16,0%, gonorrea +17,81% y herpes +30,06% a la SE 49.
- 2026 frente a 2025: sífilis +30,3%, gonorrea +10,8%, herpes +6,4% a la SE 24.

La sífilis muestra aceleración en 2026. Limón y San José aparecen repetidamente entre los territorios de mayor tasa o volumen. Los hombres predominan en sífilis y gonorrea; las mujeres en herpes.

3.6 Sarampión y enfermedades prevenibles por vacunación

En 2025 se mantuvo vigilancia de casos sospechosos y se documentó un brote de varicela en el CAI San José. En 2026 se confirmaron cinco casos de sarampión: tres importados y dos asociados a importación.

La aparición de sarampión en 2026 eleva la prioridad de mantener coberturas efectivas de 95%, cerrar brechas locales y reforzar vacunación de viajeros.

3.7 Panorama territorial integrado

- **Pacífico Central:** alta tasa de dengue en ambos años, EDA y mortalidad infantil.
- **Central Norte/Alajuela:** mayor carga de dengue en 2026, malaria en Crucitas/Los Chiles y miasis.
- **Huetar Caribe/Limón:** malaria en Matina, tasas altas de ITS, IRAS y miasis.
- **Central Sur/San José:** gran volumen de dengue en 2025, ITS, EDA, meningitis y tuberculosis.
- **Huetar Norte:** malaria, IRAG y miasis.
- **Brunca:** altas tasas de IRAG y exposición a eventos importados.
- **Chorotega/Guanacaste:** dengue, EDA y mortalidad infantil.

4. Prioridades para 2026

4.1 Población adulta mayor

7. Vacunación respiratoria y detección temprana de IRAG, con foco en mayores de 75.
8. Revisión sistemática de piel y heridas en atención domiciliaria, EBAIS y hogares de larga estancia.
9. Ruta integrada para miasis que conecte salud humana, SENASA, cuidadores y servicios sociales.
10. Tamizaje y tratamiento de ITS sin barreras por edad.
11. Prevención de caídas: evaluación del hogar, visión, audición, medicamentos y movilidad.
12. Detección de negligencia, abandono y violencia en consultas y visitas domiciliarias.
13. Evaluación de depresión y riesgo suicida, especialmente en hombres mayores de 70.
14. Publicación de indicadores separados para 65-74 y 75 y más.

4.2 País

15. Intensificar control vectorial del dengue en Orotina, Pacífico Central y Central Norte.
16. Reforzar vigilancia de EDA, agua y alimentos en territorios de alta incidencia.
17. Mantener búsqueda activa de malaria en Crucitas, Los Chiles y Matina.

- 18. Expandir prevención, diagnóstico y tratamiento de sífilis y gonorrea.
- 19. Preparar servicios para la temporada respiratoria del segundo semestre.
- 20. Mantener vacunación y respuesta rápida ante sarampión importado.
- 21. Integrar salud mental y violencia en la vigilancia rutinaria.

5. Brechas de información

- 22. Ausencia de cortes finales de 2025.
- 23. Cortes diferentes entre eventos y años.
- 24. Falta de tablas numéricas por edad para IRAG y meningitis.
- 25. Ausencia de hospitalización y mortalidad por edad para EDA.
- 26. Falta de seguimiento de violencia intrafamiliar e intentos de suicidio en 2026.
- 27. Categorías etarias no uniformes.
- 28. Posible inclusión de personas de 60-64 en el informe de violencia de “adultos mayores”.
- 29. Datos preliminares y revisables.
- 30. Ausencia de microdatos para ajustar por estructura etaria, comorbilidad y territorio.

6. Conclusiones

La transición de 2025 a 2026 no muestra una mejora uniforme. Durante el primer semestre de 2026 disminuyó la carga respiratoria total, pero aumentaron dengue, EDA, meningitis y las ITS. La malaria volvió a mostrar más transmisión local, aunque en niveles muy inferiores a los años de mayor actividad. La miasis disminuyó, pero continúa concentrándose en personas mayores.

Para la población de 65 años y más, las prioridades son más amplias que las enfermedades transmisibles. El perfil integrado incluye IRAG, miasis, sífilis, caídas, heridas, violencia, negligencia y salud mental. Los mayores de 75 años constituyen el grupo más vulnerable dentro de la población mayor.

La principal recomendación es adoptar una vigilancia gerontológica transversal: cada evento debería publicar casos, tasas, hospitalizaciones y defunciones para 65-74 y 75 y más. Sin esa desagregación, la respuesta continuará dependiendo de gráficos y análisis parciales.

Anexo. Matriz comparativa completa (2025-2026)

Tabla íntegra de comparaciones directas, tendencias parciales y hallazgos exclusivos utilizada para elaborar este informe integrado.

Evento	Indicador	Corte	2025	2026	Cambio	Comparabilidad	Interpretación
IRAG	Casos totales	SE 24	7627	4600	-39.7%	Directa	Menor carga total pero mayores de 75 continúan prioritarios
IRAS	Casos totales	SE 24	750863	649865	-13.5%	Directa	Disminución nacional
ETI	Casos totales	SE 24	10609	7212	-32.0%	Directa	Disminución nacional
Dengue	Casos totales	SE 26	1677	1805	+8.0%	Directa	Aumento sostenido desde SE 17 de 2026
EDA	Casos totales	SE 24	197139	237833	+20.6%	Directa	Mayor carga y alerta en 2026

Evento	Indicador	Corte	2025	2026	Cambio	Comparabilidad	Interpretación
Meningitis	Casos sospechosos	SE 26	109	116	+6.4%	Directa	Incremento moderado sin brote nacional
Sífilis	Casos totales	SE 24	1302	1696	+30.3%	Directa	Aceleración de la notificación
Sífilis	Casos 65 años y más	SE 24	129	151	+17.1%	Directa	Aumento absoluto en población mayor
Gonorrea	Casos totales	SE 24	637	706	+10.8%	Directa	Aumento sostenido
Herpes simple	Casos totales	SE 24	405	431	+6.4%	Directa	Aumento moderado
Miasis	Casos totales	SE 27	54	46	-14.8%	Directa	Reducción general
Miasis	Casos 65 años y más	SE 27	25	24	-4.0%	Directa	Reducción mínima y mayor concentración proporcional
Miasis	Proporción 65 años y más	SE 27	46.3%	52.2%	+5.9 puntos	Directa	Aumenta la vulnerabilidad relativa
Miasis	Cierre disponible 2025 en 65 años y más	SE 50	48 de 96	No disponible	No calculable	Tendencia parcial	La mitad de los casos de 2025 correspondió a personas mayores
Sífilis	Cierre disponible 2025 en 65 años y más	SE 49	297 de 3153	No disponible	No calculable	Tendencia parcial	Carga persistente en edades avanzadas
Gonorrea	Cierre disponible 2025 en 65 años y más	SE 49	36 de 1501	No disponible	No calculable	Tendencia parcial	Transmisión presente en edades avanzadas
Herpes simple	Cierre disponible 2025 en 65 años y más	SE 49	51 de 982	No disponible	No calculable	Tendencia parcial	Transmisión presente en edades avanzadas
Malaria	Transmisión local	SE 26	9	20	+122.2%	Aproximada	Definiciones y revisiones requieren cautela
Violencia intrafamiliar	Casos clasificados como adultos mayores	SE 35	2238	No disponible	No calculable	Hallazgo exclusivo 2025	Requiere continuidad en 2026
Intentos de suicidio	Tasa 65-69	SE 33	6.6	No disponible	No calculable	Hallazgo exclusivo 2025	Sin seguimiento comparable
Intentos de suicidio	Tasa agregada 65 años y más	SE 42	7.6	No disponible	No calculable	Hallazgo exclusivo 2025	Menor incidencia pero potencial alta letalidad
Violencia intrafamiliar	Tasa 75 años y más	SE 43	478.2	No disponible	No calculable	Hallazgo exclusivo 2025	Alta vulnerabilidad en edades avanzadas
Mortalidad externa	Otras causas externas en 65 y más	Año 2025	699	Publicado en boletín 2026	No aplica	Dato retrospectivo	Principal riesgo externo en mayores
Mortalidad externa	Homicidios en 65 y más	Año 2025	17	Publicado en boletín 2026	No aplica	Dato retrospectivo	Riesgo mínimo comparado con población general
Mortalidad	Otras causas	Año 2025	1148	Publicado en	No aplica	Dato	60.9%

Evento	Indicador	Corte	2025	2026	Cambio	Comparabilidad	Interpretación
externa	externas nacional			boletín 2026		retrospectivo	correspondió a 65 y más
Accidentes de tránsito	Defunciones nacional	Año 2025	867 (2024)	951 (2025)	+9.7%	Directa (anual)	Único indicador de mortalidad con cierre anual completo en ambos años
Dengue	Hospitalizados (dato puntual EDUS)	Sin corte comparable	4	2	No calculable	Hallazgo puntual	Ambos años sin serie nacional de hospitalización por dengue
Razón de tasas	Factor de ajuste poblacional aplicado	SE 24-27	P2025=5191000	P2026=5217000	+0.51%	Metodológico	Población implícita en tasas oficiales de dengue de cada año

Fuentes principales

- Diagnóstico epidemiológico de Costa Rica 2025 y matriz de evidencia correspondiente.
- Diagnóstico epidemiológico de Costa Rica 2026 y matriz de evidencia correspondiente.
- Boletines epidemiológicos N.º 23, 26 y 37 de 2025.
- Boletines epidemiológicos N.º 24 y 25 de 2026.